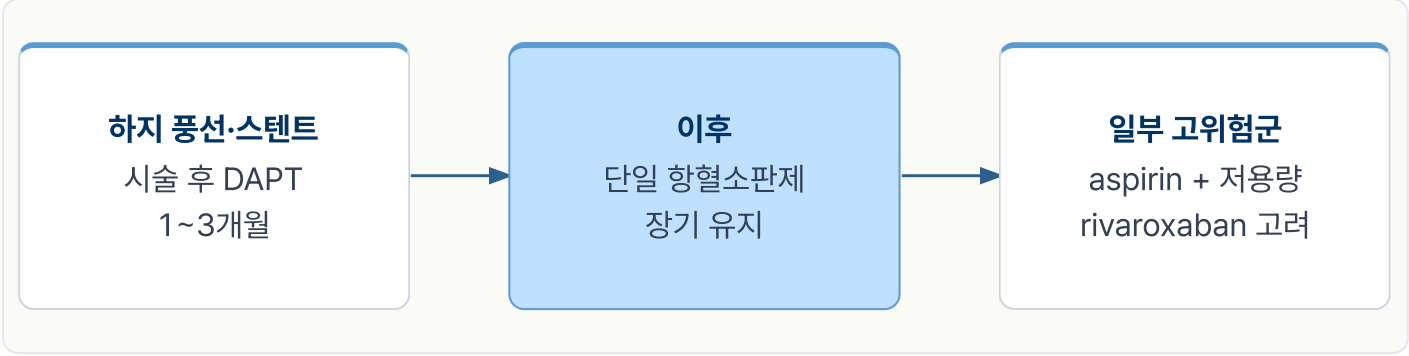
의료진 진료 카드 · ASL-014

하지 재관류 후 · 복약과 인계

시술 후 사지 사건과 심혈관 사건을 함께 관리한다. 현재 병용 단계·시술 시점·출혈과 상처 상태를 이어받는다.

연자 Q&A · 병합 기간과 장기 유지 구분



연자 Q&A · 복약 단계 인계

DAPT 기간	Aspirin + clopidogrel은 보통 1~3개월, 길어야 6개월. 평생인 것은 병합이 아니라 단일 항혈소판제(SAPT)라고 답변.
SAPT	Aspirin 100mg 또는 clopidogrel 75mg. PAD 단독에서는 clopidogrel 선호, 기존 관상동맥질환 등으로 aspirin 복용 중이면 유지한다는 연자 설명.
고위험 병합	다혈관 질환·당뇨·CKD·시술 병력에서 aspirin + rivaroxaban 2.5mg bid 고려. 출혈 또는 AF 등 다른 항응고 사유 발생 시 조정한다는 답변.

시술·내시경 협진에 전달할 복약 맥락

현재 치료 목적	사지 재관류술 시점과 DAPT 기간인지, SAPT 장기 유지인지, aspirin+rivaroxaban 병합인지 구분해 전달.
출혈·동반질환	현재 멍·코피 등 출혈, CKD·부종, AF 등 별도 항응고 사유와 약제 구성을 함께 전달. 실로스타졸은 사건 예방 약제 대체가 아니라 파행 개선 목적이다.

연자 Q&A: 실로스타졸 + aspirin + rivaroxaban 3제를 동시에 쓰는 조합은 권하지 않는다. 사건 예방과 파행 개선 중 목표에 맞춰 병합을 선택하며, 약제 수에 따른 출혈 누적을 고려한다고 답변했다.

의료진 진료 카드 · ASL-014

재관류 후 · 상처와 전신 위험

본강의의 세 목표: 사망·뇌졸중·심근경색 예방, 보행거리 향상, 창상 치유.

추적에서 함께 보는 두 사건

MACE · 전신 사건

사망·MI·뇌졸중 예방. PAD는 다혈관 죽상경화의 발현이며, 사지 치료 후에도 심혈관 위험은 꾸준히 증가한다고 설명.

MALE · 사지 사건

급성 허혈·혈전제거/용해·주요 절단·재재관류. 시술 후 초기에 사지 사건이 빠르게 쌓이며 첫해 이후 증가 속도는 완만해진다는 강의 설명.

본강의 · 위험인자 관리

지질	강의 목표 LDL <70 mg/dL·non-HDL <100 mg/dL. Atorvastatin 40~80mg qd 또는 rosuvastatin 20mg qd. 고강도 불내약이면 저강도 statin+ezetimibe.
혈압·혈당	RAS 억제제(losartan·valsartan·candesartan)·CCB를 선호, BB는 일차 선택으로 두지 않는 설명. PAD 고유 HbA1c 최적값은 명확하지 않으나 강의는 <7.0% 목표를 제시.
금연·발관리	압력 회피·매일 시진·청결·보습. Buerger병도 흡연과 관련되어 금연 강조. 강의의 금연 성공 예: 적극 상담 21.3%, 최소 상담 6.8%, varenicline 21.9%.

연자 Q&A · 다시 의뢰할 때

상처·휴식통	상처·휴식기 통증은 ABI와 무관하게 바로 의뢰. 창상 치유와 재개통 유지 여부를 함께 평가.
생활 제한 파행	CKD 4기·당뇨·파행·부종/멍 사례: 은행잎 제제 중단, clopidogrel·고강도 statin 유지, 보행운동·부종 원인 점검을 먼저. 생활 지장이 크면 재개통 가능성 의뢰.

본강의 COMPASS: 안정 죽상경화 질환 27,395명에서 aspirin+rivaroxaban은 aspirin 단독 대비 심혈관 사망·뇌졸중·MI 24% ↓, HR 0.76(95% CI 0.66~0.86). 대상 환자에서 장기 예후 개선 전략으로 소개했다.

의료진 진료 카드 · ASL-014

파행 치료 · 병합의 목적을 구분

연자 Q&A의 약물 선택과 본강의의 운동·증상 치료. 파행 개선을 사건 예방과 혼동하지 않는다.

연자 Q&A · 실로스타졸

추가 목적	생활에 지장 있는 파행에서 항혈소판제에 추가. 심부전은 중증도와 무관하게 금기. 두통·빈맥/두근거림·부종을 확인.
용량·평가	50mg bid로 시작해 증량, 약 3개월에도 보행거리 개선이 없으면 중단 가능. CKD 4기에서는 활성 대사체 축적을 고려해 저용량 시작을 답변.
대안·주의	못 견디거나 심부전으로 사용할 수 없으면 사르포그렐레이트를 대안으로 쓰나 파행 근거는 더 약하다는 연자 의견. 냉감만으로는 둘 다 시작하지 않는다.

본강의 · 보행거리 개선 근거

감독하 운동	최소 30~45분, 주 ≥3회, ≥12주(≥3개월), 통증을 느낄 때까지 운동·휴식 반복. Class I, A로 소개.
운동 연구	CLEVER 111명: 운동+약물 5.8±4.6분, 재관류+약물 3.7±4.9분, 약물 단독 1.2±2.6분 개선. 내피 기능·국소 염증·통증 역치·혈관 생성 기전.
실로스타졸 효과	교재는 12~24주 치료에 50~67% 보행거리 증가. 구두 강의는 4~12주에 약 50~70% 증가로 설명했다.

연자 Q&A · 저용량 rivaroxaban의 당시 설명

처방 조합

Rivaroxaban 2.5mg 하루 2회 + aspirin. 일반 용량 항응고와 구분. 허혈 고위험군에서 사지 사건 약 40~45% 감소로 소개.

급여 범위

당시 만 ≥65세이며 MI 후 >1년 다혈관 CAD 또는 CAD+PAD로 설명. PAD 단독·65세 미만은 전액부담, 의원/병원 차이는 없다고 답변. 제네릭 정당 약 700원·하루 1,400원 예시.

본강의의 무증상 ABI 0.91~0.99 항혈소판제 이득 설명과 증상성 PAD 치료를 구분한다. 연자 Q&A는 무증상에는 위험인자 관리 중심, 증상성·재관류 후에는 사건 예방 약제 유지로 설명했다.